

Hanseníase · diagnóstico, PQT e contatos

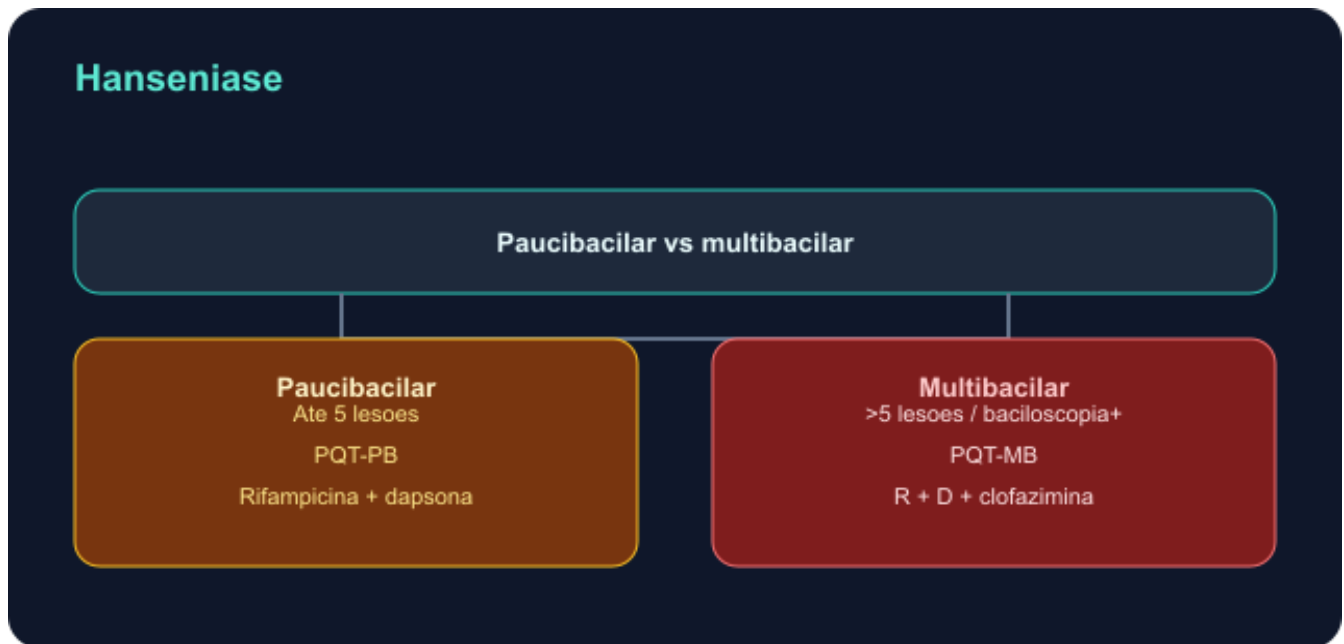
Hanseníase diagnostica-se clinicamente: lesão cutânea com alteração de sensibilidade e/ou nervo espessado. PQT cura; examinar contatos interrompe transmissão.

Achado-chave

Dica - Achado-chave

Hipostesia em placa hipocrômica/eritematosa é o clichê. Neural pura existe — avalie nervos periféricos (ulnar, tibial posterior etc.).

Número de lesões/carga bacilar define esquema de PQT e duração.



Conduta de vigilância

- Notificação compulsória; tratamento gratuito no SUS
- Exame de contatos domiciliares; BCG conforme protocolo de contatos
- Reações tipo 1 e 2: corticoide / talidomida (eritema nodoso) com regras estritas
- Prevenção de incapacidade: inspeção de pés, orifícios e fisioterapia

Diferenciais

Condição | Pista

Pitíriase versicolor | Sensibilidade normal

Tinha do corpo | Bordas ativas; KOH

Vitiligo | Acromia sem anestesia

Neuropatia diabética | Sem lesões típicas de hanseníase

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não isole o paciente sob estigma — após início da PQT a transmissão cai drasticamente. Gestante: ajustar esquema (evitar talidomida absolutamente).

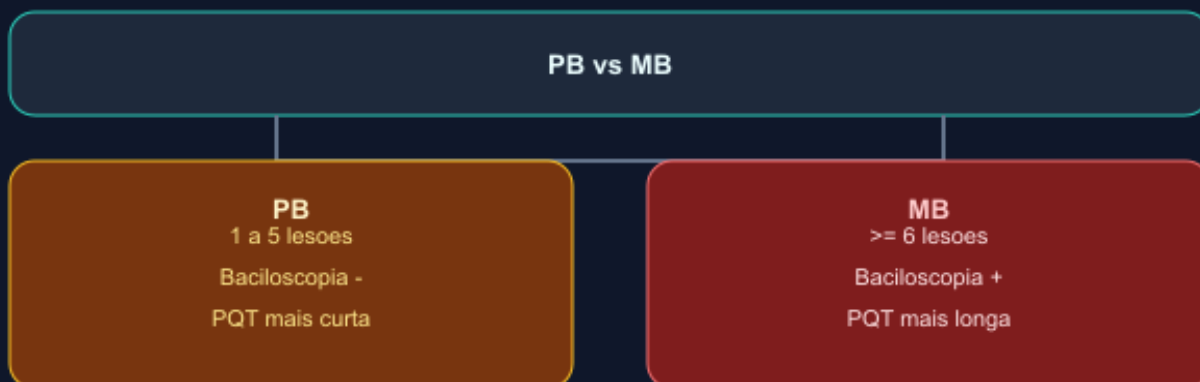
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Hanseníase: classificação operacional paucibacilar (PB) vs multibacilar (MB) guia o esquema PQT (duração e drogas).

Corte clássico: número de lesões cutâneas ($\pm$ baciloscopia) define PB ou MB.

Classificacao operacional



PQT-OMS/MS: rifampicina + dapsona ($\pm$ clofazimina no MB) sob supervisão mensal.

PQT - ideia de prova

Esquema poliquimioterapico

- 1 PB: rifampicina mensal + dapsona diaria (6 doses/6 meses)
- 2 MB: + clofazimina; esquema mais longo (12 doses/12 meses)
- 3 Dose supervisionada mensal (TDO/ideia de adesao)
- 4 Notificar e examinar contatos

PB $\times$ MB + PQT (ideia)

Item | Paucibacilar (PB) | Multibacilar (MB)

Lesões cutâneas | 1 a 5 | $\geq$ 6 (ou envolvimento mais extenso)

Baciloscopia | Negativa | Positiva (se disponível)

PQT — ideia | Rifampicina + dapsona (ciclo mais curto) | R + D + clofazimina (ciclo mais longo)

Duração típica (MS/OMS) | 6 doses mensais em até 9 meses | 12 doses mensais em até 18 meses

Clínica que ancora o diagnóstico

- Lesão(ões) com alteração de sensibilidade
- Acometimento de nervos periféricos (espessamento, déficit)
- Não precisa histologia para iniciar se critérios clínicos claros
- Reações hansênicas " falha terapêutica automática

Contatos

Lembre - Contatos

Examine comunicantes e siga protocolo de quimioprevenção/vacinação BCG conforme norma vigente do MS.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1